

FRACTURAS COSTALES

P. Cuesta Fuente, J.J. González Fernández, J.T. Camino Acha. J. Fernandez Lombardía.

INTRODUCCIÓN

Son las lesiones más frecuentes en traumatismos torácicos. El mecanismo de producción puede ser cerrado por traumatismo directo o abierto por lesión penetrante (herida de bala). Las costillas más frecuentemente afectadas son las comprendidas entre la cuarta y la décima. El síntoma fundamental es el dolor sobre la zona de la fractura, que se reproduce al palpar dicha zona y se intensifica con los cambios posturales, la tos y la inspiración profunda. Además puede aparecer crepitación a la palpación y hematoma.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico es clínico y se confirma con pruebas de imagen.

La Radiografía de tórax permite confirmar el diagnóstico, en la mayoría de los casos, puesto que un 50% de las fracturas no se visualizan en la radiografía de tórax inicial, apreciándose la fractura tardíamente. Si las condiciones lo permiten se debe realizar radiografía lateral y radiografía de parrilla costal.

TRATAMIENTO

- Constante vitales con SatO₂.
- Oxigenoterapia si SatO₂ < 94%.
- Vía venosa periférica.
- Analgesia: según escala del dolor.

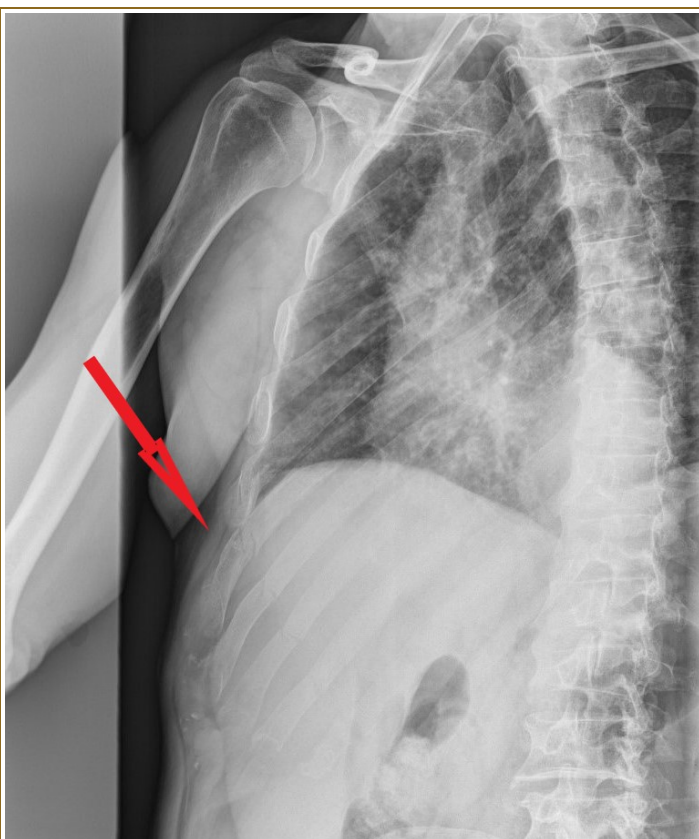
El tratamiento principal de las fracturas costales es el control del dolor mediante una adecuada analgesia: analgésicos y AINES. Hay que tener precaución con los opioides porque a altas dosis deprimen la función respiratoria. Es fundamental una correcta fisioterapia ventilatoria para prevenir complicaciones y evitar los vendajes.

Consideraciones especiales:

- Fractura costal simple: Existe dolor torácico y selectivo a la palpación externa.
- Fractura costal complicada: aparecen lesiones asociadas:
 - Precoces: desgarró pulmonar que origine neumotórax, hemotórax o contusión pulmonar.
 - Tardías: atelectasias, neumonías...
- Fractura de la 1ª, 2ª y 3ª costilla: son infrecuentes. Indican traumatismo violento. Asociadas a fracturas de clavícula o de escápula. Pueden coexistir con lesiones de grandes vasos, rotura traqueobronquial, fracturas de columna vertebral o hemo-neumotórax.
- Fractura de 4ª-7ª costilla: pueden producir hemo-neumotórax con posible enfisema subcutáneo en el foco de la fractura.
- Fractura de 8-10ª costilla: pueden originar lesiones de vísceras abdominales.
- Volet costal o tórax inestable: se define como el movimiento anómalo de la caja torácica (movimiento paradójico) producido por la fractura bifocal de dos o más costillas contiguas. Ocurre en traumatismos de gran impacto. Clínicamente aparece inestabilidad de una zona del tórax e insuficiencia respiratoria de grado variable. El tratamiento se basa en una buena ventilación, pudiendo precisar IOT con ventilación mecánica y analgesia agresiva.



Rx parrilla costal AP: fractura arcos costales derechos



Rx parrilla costal oblicua: fractura arcos costales derecho

BIBLIOGRAFÍA

- José Miguel izquierdo; Protocolo traumatismos torácicos Hospital Donostia. 2009.
- Hernández C, Sebastián F, Cabeza R, Martínez J.J. Conducta ante el traumatismo torácico. Rev. San. Serv. Vasco Salud. 3: 242-248, 1987*.
- Quesada A, Rabanal JM. Actualización en el trauma grave. Traumatismos torácicos. Ergon 2006; 211-5*.
- Mehmet Sirmali, Hasan-Turut. A comprehensive analysis of traumatic rib fractures: morbidity, mortality and management. European Journal of Cardiothoracic Surgery 2003; (24):133-8.*
- F. Barranco Ruiz, J. Blasco Morilla, A. Mende Morales, M^a. A. Muñoz Sanchez, A. Jareño Chaumel, J. Cózar Carrasco, R. Guerrero Pabón, J. Gil Cebrián, C. Martín Rubí; J.C. Rodríguez Rodríguez. Principios de Urgencias, Emergencias y Cuidados Críticos. Traumatismo torácico. SAMIUC. Alhulia, Granada 1999; 11.3: 1307-1312.
- Matto y Feliciano Moore. Trauma Cuarta edición. Mc Graw-Hill Interamericana. México 2001; Volumen 1: 507-623.
- Mayberry JC, Ham LB, Schipper PH, Ellis TJ, Mullins RJ. Surveyed opinion of American trauma, orthopedic, and thoracic surgeons on rib and sternal fracture repair. J Trauma. 2009; 66:875-9.
- Martí De Gracia M, et al. Manejo radiológico del paciente politraumatizado. Evolución histórica y situación actual. Radiología 2010;52(2):105-114.
- Perna V, Morera R. Factores pronóstico del traumatismo torácico: estudio prospectivo de 500 pacientes. Cirugía Española 2010; 87(3):165-170.